Accès direct aux IPA en CPTS : 6 départements, à partir du 1er décembre 2026

La rédaction du Cercle des Généralistes · 28 octobre 2026 · 11 min de lecture

SITUATION

Dans 6 départements, des patients pourront consulter un IPA de leur CPTS sans passer par un médecin, à partir du 1er décembre 2026 et pendant 5 ans.

Le décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026, paru au Journal officiel du 24 octobre et entré en vigueur le lendemain, organise l'expérimentation prévue par l'article 1er de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. L'arrêté du 23 octobre 2026, paru au même Journal officiel, retient l'Hérault, le Loiret, la Martinique, Mayotte, le Val-d'Oise et l'Yonne, sélectionnés à l'issue d'un appel à projet. L'expérimentation débute le 1er décembre 2026 pour 5 ans.

L'ESSENTIEL

- **Ce qui change :** dans 6 départements, un IPA qui exerce dans une CPTS pourra recevoir un patient sans orientation médicale, prescrire dans les limites fixées par arrêté, puis adresser un compte rendu au médecin traitant.
- **Quand :** décret en vigueur depuis le 25 octobre 2026 ; expérimentation à partir du 1er décembre 2026, pour 5 ans.
- **Que faire :** dans ces départements, adhérer à sa CPTS et y fixer, avant le 1er décembre, le circuit des comptes rendus et un délai de reprise des patients réorientés.

CONTEXTE

Depuis le décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, l'infirmier en pratique avancée peut déjà prendre directement en charge des patients lorsqu'il exerce dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique. Selon l'Ordre national des infirmiers, il s'agit notamment des établissements de santé et médico-sociaux, des centres de santé, des maisons de santé et des équipes de soins primaires et spécialisés. Ce décret de 2025 lui permet aussi de prescrire des produits de santé ou des prestations, soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'Académie nationale de médecine ; cet arrêté peut subordonner la prescription à un diagnostic médical préalable. Il lui impose, quand une situation dépasse son champ de compétences, d'adresser le patient « sans délai » à son médecin traitant et d'en informer « expressément » ce dernier ; en l'absence de médecin traitant, il reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée.

Pour les IPA qui exercent en CPTS, la loi du 19 mai 2023 prévoit une expérimentation de 5 ans, dans 6 départements au plus dont 2 d'outre-mer, que le décret du 23 octobre 2026 met en œuvre. Le 14 octobre 2026, le ministère de la Santé a aussi annoncé son objectif de doubler, dès 2027, le nombre d'IPA formés, et prévoit pour cela de supprimer la durée minimale d'exercice préalable à l'accès à la pratique avancée et d'ouvrir effectivement la validation des acquis de l'expérience aux IPA. Le Cercle avait présenté en juillet la position du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui juge « irremplaçable » le rôle du médecin dans la coordination des soins, dans notre article sur l'accès direct aux IPA.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur les infirmiers concernés, le décret vise l'IPA dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des 6 départements. Il déclare sa participation au directeur général de l'agence régionale de santé, au moyen d'une application sur le site internet de l'agence, et joint un document qui justifie son exercice dans une CPTS de l'un des 6 départements. L'agence publie sur son site, département par département, la liste des IPA autorisés à participer, et transmet leurs noms aux organismes locaux de sécurité sociale. Un IPA peut entrer dans l'expérimentation jusqu'à 6 mois avant sa fin.

Sur la prise en charge, l'IPA autorisé « peut, à titre expérimental, prendre en charge directement les patients ». En cas de besoin, le patient est réorienté vers son médecin traitant ou, le cas échéant, vers un médecin impliqué dans sa prise en charge ou exerçant dans la CPTS, ou, en cas d'impossibilité, vers tout autre médecin. Le décret ne fixe ni liste de motifs de consultation ni catégorie de patients.

Sur les prescriptions, le décret du 23 octobre ne fixe pas de liste propre : ce que l'IPA peut prescrire relève de l'arrêté du 25 avril 2025. Tout IPA peut notamment prescrire un arrêt de travail jusqu'à 3 jours, des transports sanitaires, des antalgiques de palier 1 et des inhibiteurs de la pompe à protons, et, sous condition d'une formation définie par arrêté, de la fosfomycine-trométamol pour une cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication, ou de l'amoxicilline pour une angine à test rapide positif à partir de 10 ans. L'IPA du domaine des pathologies chroniques stabilisées peut aussi, « sans diagnostic médical préalable », prescrire un traitement antihypertenseur de première ligne pour une hypertension de grade 1 sans retentissement, à l'exclusion des bêtabloquants, ou un traitement hypoglycémiant de première ligne chez un patient diabétique de type 2. Ces prescriptions « ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ».

Côté médecin traitant, à l'issue de la consultation, un compte rendu des soins réalisés par l'IPA lui est adressé, ou, le cas échéant, au médecin impliqué dans la prise en charge ou exerçant dans la CPTS, « par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges et la sécurisation des données transmises ». Le compte rendu est reporté dans le dossier médical partagé ou, à défaut, dans le dossier informatisé du patient.

Sur l'évaluation, chaque agence régionale de santé évalue l'expérimentation sur son territoire. Elle dresse un état des lieux et centralise chaque année des informations sur la qualité de la prise en charge, notamment le nombre d'IPA participants, le nombre de patients reçus en accès direct et leurs motifs de consultation, le nombre moyen de consultations et le nombre d'actes, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, les événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin. Le décret a été pris après les avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 14 avril 2026, de la Haute Autorité de santé du 2 juillet 2026, de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole du 13 août 2026, et des conseils de la Caisse nationale de l'assurance

maladie et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026. Selon la loi du 19 mai 2023, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 6 mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation qui « se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation ».

CE QUI POSE QUESTION

Au 28 octobre 2026, 3 questions restent ouvertes.

Comment la consultation en accès direct en CPTS sera-t-elle facturée ? La loi du 19 mai 2023 a modifié l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à la convention nationale des infirmiers la prise en charge des actes réalisés par les IPA, « le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin ». Une décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026, parue au Journal officiel du 22 octobre, crée à partir du 6 novembre une consultation IPA cotée PAI 2,1, facturable 4 fois par an et par patient, et des forfaits de suivi en cas d'accès direct, dans les situations « définies par le code de santé publique ». L'expérimentation en CPTS relève, elle, de la loi de 2023 et du décret du 23 octobre, qui ne fixe aucun tarif ; aucun texte ne dit si ces cotations s'y appliquent.

Dans quel délai le médecin traitant reprendra-t-il un patient réorienté ? Le décret du 23 octobre prévoit une réorientation « en cas de besoin », sans fixer de délai. Le décret de janvier 2025 impose à l'IPA, quand la situation dépasse ses compétences, d'adresser le patient « sans délai » à son médecin traitant pour permettre une prise en charge médicale « dans un délai compatible avec l'état du patient », sans dire qui garantit ce délai.

Sur quels critères de réussite l'expérimentation sera-t-elle jugée ? Le décret confie l'évaluation aux agences régionales de santé, territoire par territoire, et liste des données à recueillir, sans fixer de seuil de réussite. La loi prévoit un rapport d'évaluation au Parlement, sans en fixer les critères.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour un généraliste de ces 6 départements, une partie de ses patients pourra consulter d'abord l'IPA de la CPTS. Il recevra alors un compte rendu à lire et à intégrer au dossier, des patients réorientés à reprendre, et parfois un traitement instauré sans lui, dont le renouvellement suppose une concertation médicale. Le décret ne prévoit aucune rémunération du médecin traitant pour ce travail de coordination.

L'organisation repose sur la CPTS : c'est l'exercice dans la CPTS qui ouvre l'accès direct, et c'est vers un médecin impliqué dans sa prise en charge ou exerçant dans la CPTS que le patient peut, le cas échéant, être réorienté à la place de son médecin traitant. Le généraliste qui n'est pas membre de sa CPTS recevra les comptes rendus de ses patients sans participer à l'organisation du circuit.

Hors de ces 6 départements, rien ne change pour les IPA en CPTS ; l'accès direct reste possible, depuis janvier 2025, dans les établissements de santé et médico-sociaux et dans les structures d'exercice coordonné prévus par la loi.

LE REGARD DU CERCLE

Le décret encadre sérieusement l'accès direct. L'IPA doit exercer dans une CPTS et se déclarer à l'agence régionale de santé, le compte rendu au médecin traitant est obligatoire après chaque consultation et rejoint le dossier médical partagé ou, à défaut, le dossier informatisé du patient, et l'évaluation suivra les événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin. Pour un patient qui n'obtient pas de rendez-vous, une consultation infirmière qualifiée, suivie d'un compte rendu à son médecin, vaut mieux qu'une absence de consultation.

Mais le décret fait reposer la sécurité du dispositif sur le médecin traitant sans le reconnaître. C'est lui qui reçoit les comptes rendus, reprend les patients réorientés et répond quand la situation dépasse l'IPA, sans délai fixé, sans moyen dédié et sans rémunération. L'IPA pourra instaurer, sans diagnostic médical préalable, un antihypertenseur ou un antidiabétique de première ligne ; le médecin traitant le découvrira par compte rendu, et le renouvellement passera par une « concertation médicale » que personne n'organise. La liste du décret, qui n'est pas limitative, cite le pourcentage de patients orientés vers un médecin, mais ni le délai de leur reprise ni les consultations faites 2 fois pour le même motif. Le Cercle demande que les agences régionales de santé mesurent ces 2 points dès la première année : ce sont eux qui diront si l'accès direct a libéré du temps médical ou s'il en a consommé.

La suite se joue dès maintenant. Le ministère veut doubler dès 2027 le nombre d'IPA formés, la loi demande au rapport final de se prononcer « sur la pertinence d'une généralisation », et l'Ordre national des infirmiers veut que l'expérimentation se traduise, « à terme », par « un accès direct pérenne et généralisé pour tous les patients ». Le circuit que les CPTS de ces 6 départements vont fixer servira de modèle. Le généraliste qui siège dans sa CPTS pourra en écrire les règles ; celui qui reste en dehors en recevra les comptes rendus.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin installé dans l'un des 6 départements** : Adhérer à sa CPTS s'il n'en est pas membre, puis y faire fixer, avant le 1er décembre, le canal sécurisé des comptes rendus et un délai de reprise des patients réorientés.

Sources

Décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026 relatif à l'expérimentation permettant aux infirmiers en pratique avancée participant à une communauté professionnelle territoriale de santé de prendre en charge directement les patients

Arrêté du 23 octobre 2026 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation permettant aux infirmiers en pratique avancée participant à une communauté professionnelle territoriale de santé de prendre en charge directement les patients

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée

Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique

Décision du 8 septembre 2026 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie

Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, article 1er

Ministère de la Santé, Démographie des professionnels de santé : une hausse historique des effectifs formés et de nouvelles mesures pour renforcer l'accès aux soins (14 octobre 2026)

Ordre national des infirmiers, Accès direct aux infirmiers en pratique avancée : l'Ordre national des infirmiers salue une nouvelle étape franchie pour améliorer l'accès aux soins (26 octobre 2026)

Traçabilité : décret n° 2026-985 et arrêté du 23 octobre 2026, Journal officiel n° 249 du 24 octobre 2026, lus en entier ; décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, lu en entier ; arrêté du 25 avril 2025, Journal officiel n° 102 du 30 avril 2025, et décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026, Journal officiel n° 247 du 22 octobre 2026, lus en entier ; loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, article 1er, dans sa version en vigueur au 27 octobre 2026 ; ministère de la Santé, communiqué du 14 octobre 2026. L'Ordre national des infirmiers est cité comme acteur, pour la liste des structures où l'accès direct est déjà possible et pour sa position.